

() ACOMPANHAMENTO (X) CONSULTA

NS

CARLOS EDUARDO KNEIPP

IDADE: 60a PESO: 105 ALTURA: 1,68 PROFISSÃO: Empregado

SINTOMAS: sonolência diurna / Azia / Infecções de faringe.

QUEIXAS: Ronco

MEDICAMENTOS: Glifage, Vagor (DM), Eutirox (tiroide); Simvastatina

MÉDICO: Dr. Ginel

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: - pilates 2x; caminhada 2x semana

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: (X) N JANTAR: S 18h

HORA QUE DORME: 22h30' 23h HORA QUE ACORDA: 06h 06h30

COCHILHO: (X) S () N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: (X) S () X NA SEMANA () N final semana

FUMO: (X) S () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 2 a 3 por dia

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO/NOITE: (X)

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: sim MALLAMPATI: III IAH: 93.5 e/h SPO2: 77%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Hipotireoidismo, Dislipolemia

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA tem Desvio de Septo

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: sim

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAFIA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

ECO - com Fe: 67%.

sim

→ 23/10/2024 Avaliação Auto 4 a 12 cmH₂O mais duas vezes - Villav (M)

→ 01/11/2024 P: 6.3 cmH₂O Bem adaptado
IAH = 0.2 e/h Auto 5 a 10 cmH₂O
m. de uso = 7h50' + tempo 5cmH₂O P: 6 a 10 cmH₂O
fuga = 11 l/min

07/11 P: 10 cmH₂O - 5cmH₂O - Dificuldade p/ dormir do
24 IAH = 0.7 lado (E)
m. de uso = 7:30 - O sono zero e melhorou
fuga = 6.0 a sonolência diurna.
- ↓ a secreção da orofaringe

09/01 P: 7.1 med. Os sintomas acabaram.
25 IAH = 0.2 e/h
m. de uso: 7h14'

21/01/26 P: med: 7,1 cm lto Serenil: 9,9

IAH: 0,1

med. uso: 7h30

fuga: 8l/min

*horo máx pillow (M) *
e filtro

região Biologia remane que vem

SINTOMAS:	
QUEIXAS:	
MEDICAMENTOS:	
MÉDICO:	
MARCAPASSO: () S () N () COMPANHHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N	
EXERCÍCIO FÍSICO:	
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: LANCHE: JANTAR:	
HORA QUE DORME:	
COCHILHO: () S () N	
DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTE	
TEM FILHOS: () S () N () DORMEM NO QUARTO: () S () N () PET NO QUARTO: () S () N	
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () N () X NA SEMANA () N	
FUMO: () S () N () MAÇÓDIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: () S () N	
TIPO DE RESPIRAÇÃO:	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:	
CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
BANHEIROINOTE: () X	
MALAMPAFI: () S () N	
IAH: () S () N () SPOZ: () S () N	
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:	
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA	
HIPERTENSÃO DA OBESIDADE:	
COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA	
() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS:	
POLISONOGRAFIA COM CPAP: () S () N () SPOZ CPAP: () S () N	
PRESSÃO NO EXAME:	

Nome: CARLOS EDUARDO KNEIPP

Data de Nascimento: 10-9-1964

RG: 37.28

Nome do Paciente

Data de exame: 19-08-2024

Peso: 105 kg

Altura: 1,68 m

Médico: DR. GISEL CALDAS JUNIOR

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 19-08-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 496,9 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 1,5 e 164,0 minutos. O tempo total de sono foi de 408,0 min, eficiência de 82,1% (tempo > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,5%; estágio N2: 72,9%; estágio N3: 4,7%; sono REM: 20,6%. O índice de despertares foi de 10/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 93,1/hora, sendo 98 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 14 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e a mínima de 77%, permanecendo 18,4% do tempo de sono com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 45 - 94 bpm e no NREM de 52 - 105 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e do teste de Epworth (6), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
Porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
Índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 93,1/hora;
Grave dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=77%);
Índice para o sono REM aumentada;
Aumento do número de despertares breves;
Presença de ronco durante o sono.

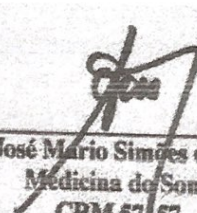
Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57